

Les dysphagies

Dr B.Abdelwahed

Faculté de médecine de Monastir

Service de Gastroentérologie de Monastir

Cas clinique

1-Patient âgé de 26 ans, sans antécédents pathologiques notables, consulte pour dysphagie apparue il y a 2 ans, d'évolution intermittente, intéressant aussi bien les solides que les liquides. Cette dysphagie survient volontiers quand il est stressé. Il n'existe pas d'amaigrissement.

A- Il s'agit d'une dysphagie de type fonctionnel.

B- Sémiologiquement, cette dysphagie peut être qualifiée de paradoxale.

C- Le premier examen à demander est une manométrie œsophagienne.

D- Le premier examen à demander est une FOGD avec biopsies œsophagiennes systématiques.

E- Une FOGD permet de retenir un TMO primitif.

Réponse: A, D

QCM

- 2- La dysphagie de **type organique** :

A- Est permanente.

B- Est progressive.

C- Prédomine sur les solides.

D- Est secondaire à un trouble moteur de l'œsophage.

E- Peut être secondaire à une cause bénigne.

Réponse: A, B, C, E

QCM

3- La dysphagie de **type fonctionnel** :

A- Est capricieuse.

B- Est non sélective voire paradoxale.

C- Est toujours secondaire à un TMO primitif.

D- La FOGD est souvent normale.

E- La manométrie est souvent normale.

Réponse: A, B, D

QCM

4- Concernant la dysphagie oro-pharyngée :

- A- La localisation de la dysphagie au niveau cervical par le patient est pathognomonique d'une cause haute.
- B- Est le plus souvent organique.
- C- Peut être secondaire à un cancer du pharynx.
- D- Peut être secondaire à un cancer du larynx sus-glottique.
- E- Peut être secondaire à un cancer du larynx sous glottique.

Réponse: B, C, D

QCM

5- Parmi les causes organiques de dysphagie oro-pharyngée , on retient:

A- Le cancer de la langue.

B- Le cancer de la glotte.

C- Les compressions extrinsèques.

D- Une angine.

E- Un diabète.

Réponse: A, C, D, E

QCM

6- Parmi les causes de dysphagie œsophagienne on retient :

A- Une pharyngite.

B- Un cancer de l'œsophage.

C- Un syndrome de Plummer Vinson.

D- Un cancer du larynx.

E- Une sténose caustique.

Réponse: B, C, E

QCM

7- Concernant la dysphagie :

- A- La localisation du niveau du blocage par le patient permet de prédire avec certitude le niveau d'obstacle.
- B- Le début brutal oriente vers une dysphagie due à un corps étranger.
- C- L'intoxication alcoolo-tabagique est un élément anamnestique à rechercher systématiquement devant une dysphagie.
- D- Une histoire de RGO oriente vers une dysphagie organique.
- E- Le caractère permanent et progressif oriente vers une étiologie fonctionnelle.

Réponse: B, C, D

QCM

8- Parmi les **causes** de dysphagie organique on retient :

A- Une achalasie.

B- Une sténose œsophagienne.

C- Une compression extrinsèque.

D- Une œsophagite.

E- Un cancer de l'œsophage.

Réponse: B C D E

QCM

9- Concernant les tumeurs de l'œsophage :

- A- La dysphagie est souvent le symptôme révélateur.
- B- Elles peuvent être bénignes ou malignes.
- C- L'adénocarcinome est le cancer le plus fréquent.
- D- La FOGD avec biopsies permet de confirmer le diagnostic de carcinome épidermoïde de l'œsophage.
- E- La FOGD permet de poser le diagnostic de léiomyome.

Réponse: A B D

10- Chez un malade ATCD de RGO, la survenue d'une dysphagie oriente vers :

A- Une sténose peptique.

B- Un adénocarcinome de l'œsophage

C- Un carcinome épidermoïde de l'œsophage

D- Une achalasie

E- Une tumeur sous muqueuse

Réponse: A B

11- Concernant le cancer de l'œsophage

- A. L'intoxication alcool-tabagique est un facteur de risque de l'adénocarcinome
- B. Le carcinome épidermoïde est le type histologique le plus fréquent.
- C. Est plus fréquent chez la femme
- D. La dysphagie est le signe révélateur le plus fréquent.
- E. Le pronostic est mauvais.

Réponse: B D E

- Concernant le cancer de l'œsophage :
 - A- L'adénocarcinome survient sur EBO.
 - B- L'EBO est un cancer in-situ.
 - C- L'adénocarcinome peut s'associer à un cancer ORL.
 - D- Le carcinome épidermoïde peut s'associer à un cancer ORL
 - E- Le diagnostic repose sur l'endoscopie avec biopsies.

Réponse: A D E

- Concernant le léiomyome :

A- Il s'agit d'un cancer de l'œsophage

B- Est fréquent.

C- Pose un problème de diagnostic différentiel avec les compressions extrinsèques.

D- Le diagnostic repose sur les biopsies endoscopiques

E- Le diagnostic repose sur l'échoendoscopie.

Réponse: C E

QCM

10- La sténose peptique :

- A- Est une sténose maligne de l'œsophage.
- B- Complique un RGO connu ou méconnu.
- C- L'aspect endoscopique est typiquement une sténose centrée, régulière, sans bourgeons ni ulcérations.
- D- Devant un aspect endoscopique typique de sténose peptique, les biopsies sont inutiles.
- E- Le Transit œsophagien doit être indiqué devant toute sténose non franchie à l'endoscopie.

Réponse: B C E

QCM

11- Concernant les sténoses œsophagiennes :

- A- Elles peuvent être bénignes ou malignes.
- B- La sténose caustique survient 2 à 12 semaines après l'ingestion de caustique.
- C- Les biopsies ne sont pas nécessaires en cas de sténose radique.
- D- La dysphagie après une chirurgie anti-reflux peut être organique ou fonctionnelle.
- E- Une dysphagie peut traduire une sténose anastomotique après gastrectomie.

Réponse: A B D E

QCM

12- La dysphagie qui survient après ingestion d'un corps étranger :

- A- Traduit un blocage du corps étranger au niveau de la lumière œsophagienne.
- B- La FOGD doit être réalisée en urgence.
- C- L'extraction du corps étranger peut être différée de quelques jours.
- D- Le principal risque est la perforation digestive.
- E- Une impaction alimentaire chez un jeune doit faire suspecter une œsophagite à éosinophiles.

Réponse: A B D E

QCM

13- Chez un patient souffrant de RGO, la survenue d'une dysphagie oriente plutôt vers :

A- Une œsophagite peptique.

B- Une œsophagite médicamenteuse due aux IPP.

C- Une sténose peptique.

D- Un carcinome épidermoïde.

E- Un adénocarcinome.

Réponse: A C E

QCM

14- Concernant les œsophagites :

- A- La dysphagie est souvent douloureuse.
- B- Les lésions prédominent au niveau du bas œsophage dans les œsophagites médicamenteuses.
- C- Les bisphosphonates et les AINS sont une cause d'œsophagite médicamenteuse.
- D- La réalisation de biopsies est systématique devant un aspect typique d'œsophagite candidosique.
- E- Les œsophagites virales et candidosiques surviennent le plus souvent chez les immunodéprimés.

Réponse: A C E

Cas clinique (2)

15- Patient âgé de 18 ans, suivi pour asthme allergique, consulte pour dysphagie aux solides, sans retentissement sur l'état général.
L'interrogatoire révèle la notion d'épisodes d'impaction alimentaire.

a- Quel est le diagnostic le plus probable :

- A- Une œsophagite à éosinophiles.
- B- Une œsophagite virale.
- C- Une sténose caustique.
- D- Une achalasie.
- E- Un syndrome de Plummer Vinson.

Réponse: A

Cas clinique (2)

b- En faveur de ce diagnostic on retient :

A- Le sexe masculin.

B- L'âge jeune.

C- Le terrain atopique.

D- L'absence de retentissement sur l'état général.

E- L'antécédent d'impaction alimentaire.

Réponse: B C E

Cas clinique (2)

c- Quels sont les signes endoscopiques en faveur de ce diagnostic :

A- La présence d'ulcérations œsophagiennes.

B- Le signe de ressaut.

C- Un aspect pseudo-trachéal.

D- La présence de sillons longitudinaux.

E- La présence de dépôts blanchâtres.

Réponse: C D E

Cas clinique (2)

d- Comment confirmer ce diagnostic ?

A- Par une manométrie œsophagienne.

B- Par un transit œsophagien.

C- Par la réalisation d'au moins 3 biopsies œsophagiennes.

D- Par la mise en évidence d'une hyperéosinophilie intra-épithéliale $> 15/$ champ à fort grossissement sur les biopsies œsophagiennes.

E- Par une épreuve thérapeutique positive aux corticoïdes.

Réponse: D

QCM

16- Parmi les causes de dysphagies organiques on retient :

A- L'obstruction fonctionnelle du SIO.

B- L'œsophage marteau-piqueur.

C- L'achalasie secondaire.

D- Le cancer de l'œsophage.

E- L'œsophagite mycosique.

Réponse: D E

QCM

17- Le diverticule de Zenker :

- A- Est un diverticule de pulsion.
- B- Se développe à partir de la paroi postérieure de l'œsophage.
- C- Se développe à partir de la paroi postérieure du pharynx.
- D- Est une cause de dysphagie pharyngée.
- E- Est une cause de dysphagie œsophagienne.

Réponse: A C E

QCM

18- Quels sont les éléments en faveur d'un diverticule de Zenker chez un patient qui consulte pour dysphagie ?

A- L'âge jeune.

B- Des régurgitations spontanées ou provoquées par la palpation cervicale.

C- La perception de bruits hydroaériques au niveau du cou.

D- Une halitose.

E- Des fausses routes.

Réponse: B C D E

QCM

19- Concernant de diverticule de Zenker :

- A- Le premier examen à demander est une FOGD devant une forte suspicion clinique d'un diverticule de Zenker.
- B- Le transit baryté montre typiquement une image d'addiction, qui comprime plus ou moins l'œsophage cervical.
- C- La FOGD est contre indiquée.
- D- Les principales complications sont les infections broncho-pulmonaires en raison des fausses routes fréquentes.
- E- La dégénérescence est possible mais rare.

Réponse: B D E

Cas clinique (3)

20- Patiente âgée de 35 ans, suivie pour anémie ferriprive, consulte pour dysphagie localisée au niveau cervical, sans signes ORL associé apparue il a 5 mois.

a- Quel est le diagnostic le plus probable ?

A- Une œsophagite peptique.

B- Une achalasie.

C- Un syndrome de Plummer Vinson.

D- Un cancer de l'hypopharynx.

E- Phlegmon péri-amygdalien.

Réponse: C

Cas clinique (3)

b- Quel est le premier examen à demander :

A- une manométrie.

B- Une FOGD.

C- Un transit baryté.

D- Une NFS.

E- Un scanner cervical.

Réponse: B

Cas clinique (3)

c- Que montre typiquement cet examen :

A- Une anémie ferriprive.

B- Un rétrécissement de l'œsophage cervical en regard de C6-C7.

C- Une membrane annulaire au niveau de l'œsophage cervical.

D- Une importante stase œsophagienne.

E- Une tumeur cervicale.

Réponse: C

QCM

21- Le syndrome de Plummer Vinson :

- A- Est plus fréquent chez les jeunes de sexe masculin.
- B- Doit être suspecté devant une dysphagie haute chez une patiente avec une anémie ferriprive.
- C- Est une cause de dysphagie de siège cervical.
- D- Est une cause de dysphagie oro-pharyngée.
- E- Peut se compliquer un cancer du pharynx et d'un adénocarcinome de l'œsophage.

Réponse: B C

QCM

22- Concernant le syndrome de Plummer Vinson :

- A- Il s'agit d'une maladie fréquente.
- B- Il s'agit d'une néoplasie.
- C- Les biopsies de la région péri-membranaire sont systématiques.
- D- Le traitement repose sur la dilatation endoscopique et la supplémentation martiale.
- E- Le risque de dégénérescence impose une surveillance endoscopique.

Réponse: C D E

QCM

23- L'anneau de Schatzki :

- A- Est une cause de dysphagie organique
- B- Est plus fréquent en cas de hernie hiatale.
- C- Est une lésion pré-néoplasique.
- D- Est un diaphragme muqueux annulaire de l'œsophage cervical.
- E- Son traitement repose essentiellement sur les dilatations endoscopiques.

Réponse: A B E

QCM

24- Parmi ces étiologies, lesquelles sont des TMO primitifs:

A- La maladie de Chagas.

B- Le lupus.

C- La pseudo-achalasie.

D- Les spasmes diffus de l'œsophage.

E- Le mégaoesophage idiopathique.

Réponse: D E

QCM

25- Le TMO primitif le plus fréquent est :

A- L'achalasie.

B- L'obstruction fonctionnelle du SIO.

C- Les spasmes diffus de l'œsophage.

D- Œsophage marteau-piqueur.

E- L'hypopéristaltisme œsophagien.

Réponse: A

Cas clinique (4)

26- Patiente âgée de 40 ans, se plaint d'une dysphagie depuis 4 ans. Il s'agit d'une dysphagie intermittente, qui intéresse surtout les liquides. Elle rapporte depuis 3 mois, la notion de pyrosis et de régurgitation et de douleurs thoraciques. Il existe un discret amaigrissement. Elle rapporte également la notion de dysphagie chez la sœur aînée.

a- Quel est le diagnostic le plus probable :

- A- Une achalasie primitive.
- B- Une achalasie secondaire.
- C- Un TMO secondaire à une maladie de système.
- D- Une sténose peptique.
- E- Un cancer de l'œsophage.

Réponse: A

Cas clinique (4)

b- En faveur de ce diagnostic :

A- Le caractère ancien de la dysphagie.

B- Le caractère paradoxal de la dysphagie.

C- Le sexe féminin.

D- L'amaigrissement.

E- La notion de dysphagie chez la sœur.

Réponse: A B E

Cas clinique (4)

c- Chez cette patiente :

- A- Le premier examen à demander est un transit œsophagien baryté.
- B- Le premier examen à demander est une FOGD.
- C- Le premier examen à demander est une manométrie œsophagienne.
- D- La FOGD permet de retenir le diagnostic présumé le plus probable.
- E- La manométrie œsophagienne permet de retenir le diagnostic présumé le plus probable.

Réponse: B E

QCM

27- Concernant l'achalasie primitive :

- A- Elle est encore appelée mégaoesophage idiopathique ou cardiospasme.
- B- Il s'agit d'un TMO primitif fréquent.
- C- Il existe une prédominance féminine.
- D- Une plus forte prévalence avec le HLA DQ W1 a été rapportée.
- E- La physiopathologie est imparfaitement élucidée.

Réponse: A D E

QCM

28- Concernant l'achalasie :

- A- une prédisposition familiale a été rapportée.
- B- L'innervation cholinergique est altérée.
- C- Il existe un dysfonctionnement du système nerveux inhibiteur de l'œsophage impliquant l'acétylcholine.
- D- L'atteinte nerveuse touche aussi bien le corps œsophagien que le SIO.
- E- Elle serait la conséquence d'une inflammation jusqu'à la destruction du plexus myentérique.

Réponse: A D E

QCM

29- Au cours de l'achalasie primitive :

- A- Certains virus ont été incriminés dans la physiopathologie.
- B- La dysphagie est intermittente, plus marquée pour les solides.
- C- La dysphagie peut disparaître à l'inspiration profonde.
- D- Il existe un important retentissement sur l'état général.
- E- Les régurgitations tardives apparaissent à un stade tardif de la maladie.

Réponse: A C E

QCM

30- Au cours de l'achalasie primitive, la FOGD :

- A- Peut montrer une sténose œsophagienne infranchissable.
- B- Est le plus souvent normale.
- C- Peut montrer une stase œsophagienne.
- D- La sensation de ressaut est pathognomonique.
- E- Peut montrer un aspect infiltré du cardia.

Réponse: B C

QCM

31- Concernant l'achalasie primitive :

- A- Le diagnostic peut être retenu devant un apéristaltisme œsophagien avec défaut de contraction du SIO à la manométrie.
- B- L'apéristaltisme œsophagien est un signe constant.
- C- Le défaut de relaxation peut s'associer à une hypertonie de base du SIO.
- D- La manométrie conventionnelle révèle une pression de relaxation intégrée au niveau du SIO > 15 mmHg.
- E- La manométrie permet de différencier entre l'achalasie primitive et secondaire.

Réponse: B

QCM

32- La manométrie conventionnelle :

- A- Doit être indiquée de première intention devant une dysphagie de type organique.
 - B- Doit être indiquée de première intention devant une dysphagie de type fonctionnelle.
 - C- Permet de retenir le diagnostic de l'achalasie.
 - D- Permet de diagnostiquer l'achalasie ainsi que son sous-type.
 - E- Est moins performante que la MHR dans le diagnostic des TMO.
- Réponse: C E

QCM

33- La MHR :

- A- Est actuellement l'examen de référence dans le diagnostic des TMO.
- B- Permet de sous classer l'achalasie en 3 types.
- C- Permet de retenir une achalasie devant une pression de relaxation intégrée $> 15\text{mmHg}$ au niveau du SIO quelque soit le péristaltisme de l'œsophage.
- D- Permet de faire la différence entre achalasie primitive et secondaire.
- E- Permet dans certains cas de différencier entre hypopéristaltisme œsophagien et achalasie.

Réponse: A B E

QCM

34- Concernant les sous-types d'achalasie :

- A- Leur diagnostic peut se faire par la manométrie conventionnelle.
- B- Le type I correspond à l'achalasie avec pressurisation de l'œsophage.
- C- Le type II correspond à l'achalasie « classique ».
- D- Le type III correspond à l'achalasie spastique.
- E- Le type III est fréquemment associé à des douleurs thoraciques.

Réponse: D E

QCM

35- Le transit œsophagien au cours de l'achalasie :

- A- A une excellente rentabilité diagnostique.
- B- Il existe toujours une disparition de la poche à air gastrique.
- C- Montre une dilatation œsophagienne dans les formes évoluées.
- D- Peut montrer une sténose irrégulière du bas œsophage.
- E- Peut montrer un aspect en bec d'oiseau du bas œsophage

Réponse: C E

QCM

36- Au cours de l'achalasie :

- A- L'amaigrissement important doit faire évoquer une dégénérescence.
- B- Les douleurs thoraciques ne se voient que dans les formes évoluées.
- C- Les régurgitations se voient essentiellement dans les formes évoluées.
- D- Dans les formes évoluées, la dysphagie devient permanente.
- E- Dans les formes évoluées, on peut observer un amaigrissement important même en l'absence de dégénérescence.

Réponse: A C D E

QCM

37- Concernant les complications de l'achalasie :

A- La dégénérescence survient habituellement après une longue durée d'évolution.

B- L'adénocarcinome est le type histologique le plus fréquent.

C- Les complications broncho-pulmonaires surviennent à un stade tardif.

D- L'œsophagite de stase peut se compliquer d'une greffe candidosique.

E- Il n'existe jamais de dénutrition.

Réponse: A C D

QCM

38- Les TMO qui touchent le péristaltisme œsophagien sont :

A- l'obstruction fonctionnelle du SIO.

B- L'achalasie.

C- L'œsophage marteau-piqueur.

D- L'hypopéristaltisme œsophagien.

E- Le spasme œsophagien.

Réponse: B C D E

QCM

39- Les TMO qui touchent le SIO sont :

A- L'obstruction fonctionnelle du SIO.

B- L'achalasie.

C- L'œsophage marteau-piqueur.

D- L'hypopéristaltisme œsophagien.

E- Le spasme œsophagien.

Réponse: A B

QCM

40- Les principaux diagnostics différentiels manométriques de l'achalasie sont :

- A- L'obstruction fonctionnelle du SIO.
- B- L'œsophage marteau-piqueur.
- C- L'hypopéristaltisme œsophagien.
- D- Le spasme œsophagien.
- E- Les maladies de système.

Réponse: A C E

QCM

41-Le spasme œsophagien :

- A- Est le TMO primitif le plus fréquent.
- B- La symptomatologie est dominée par des douleurs thoraciques.
- C- La dysphagie est de type fonctionnel.
- D- Est caractérisée par des contractions œsophagiennes amples
- E- Le Transit œsophagien peut montrer un aspect en pile d'assiette.

Réponse: B C D E

QCM

42-L'œsophage marteau-piqueur :

- A- Est un TMO rare.
- B- Peut être idiopathique ou secondaire à une sténose du bas œsophage.
- C- Peut compliquer une œsophagite à éosinophiles.
- D- Il existe une hypertonie et un défaut de relaxation du SIO.
- E- La MHR révèle une intégrale de contractions distales >8000 mmHg.s.cm.

Réponse: A B E

Cas clinique (5)

43- Patient âgé de 75 ans, suivi pour arthrose du genou sous AINS, consulte pour dysphagie intermittente, paradoxale, associée à un amaigrissement chiffré à 15 kg en 6 mois. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A- Un cancer de l'œsophage.
- B- Un cancer du cardia.
- C- Une achalasie primitive.
- D- Une pseudo-achalasie.
- E- Une œsophagite aux AINS.

Réponse: D

QCM

44- Les troubles moteurs secondaires de l'œsophage :

- A- Peuvent être secondaires à une infiltration neurologique diffuse.
- B- Le SIO est relativement respecté dans les maladies de système.
- C- La pseudo-achalasie est secondaire à une néoplasie.
- D- La FOGD est souvent anormale.
- E- La manométrie permet dans certain cas de les différencier d'un TMO primitif.

Réponse: A D C

QCM

45- Quels sont les examens complémentaires qui permettent de différencier l'achalasie secondaire de l'achalasie primitive:

A- La FOGD.

B- La manométrie.

C- Le scanner Thoraco-Abdomino-pelvien.

D- L'échoendoscopie œsophagienne.

E- La recherche des anticorps anti-neurones.

Réponse: « A », C D « E »

QCM

46- Concernant l'achalasie secondaire :

- A- Elle survient le plus souvent chez des sujets jeunes.
- B- Est toujours secondaire à une infiltration du plexus myentérique par une tumeur locale.
- C- Peut être secondaire à un carcinome.
- D- Peut être secondaire à un lymphome.
- E- L'infiltration tumorale peut être suspectée lors de la FOGD.

Réponse: C D E

Bon courage à toutes et à tous!